



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PELAYANAN IGD INSTALASI
GAWAT DARURAT
2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

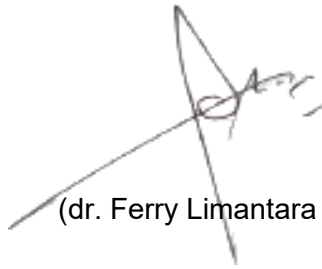
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pengorganisasian
Instalasi Gawat Darurat Tahun
2025

Disusun oleh:
Kepala Instalasi Gawat Darurat



(dr. Ferry Limantara Sp.EM)

Disetujui Oleh :
Autorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh:
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Heni Indra Wulansari, S.Kep.Ns.M.Kep)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah , M.Kes. AFP

PENYUSUN

1. dr. Ferry Limantara ., Sp.EM
2. dr. Achmad Fauzan Ailani
3. dr. Tania Calista
4. dr. Nejoa Ermaq Fatreciano
5. dr. Wahyu Firmansyah
6. dr. Moch. Dicky Wahyu Irawan
7. dr. Nurdiana Rahmadani
8. dr. Ahmad Ridho Mustawa
9. dr. Yuriansyah Dwi Rahmaputra
10. dr. Moch. Choiruz Zaman
11. Aini Nur Rokhma., Amd.Kep
12. Nurul Karima., Amd.Kep
13. Ns. Liliani Permata Sari., S.Kep
14. Ns. Sri Rahayu Kurniawati., S.Kep
15. Ns. Siti Rahmawati., S.Tr.Kep
16. Ns. Lilis Ernawati, S.Tr.Kep
17. Ns. Eka Indah Restati, S.Kep
18. Titik Nur Fadilah, Amd.Kep
19. Syarif Hidayatulloh, Amd.Kep
20. Ns. Siti Kholifah, S.Kep
21. Ns. Wisnu Aji Nugroho, S.Kep
22. Muhammad Abil, Amd.Kep
23. Intania Cahya Andini, Amd.Kep
24. Ns. Asma Yudhi Efendi, S.Kep
25. Ns. Liliani Permatasari, S.Kep
26. M. Bagus Khafidti, Amd.Kep
27. Ns. Lilis Setiyowati, S.Kep
28. Ns. Leni Narulita, S.Kep
29. Tiara Sofa Febry Firyanti, Amd.Kep
30. Ns. Isna Setya Wati, S.Kep
31. Ns. Veni Febriyanti, S.Kep
32. Ns. Tatan Lestari, S.Kep
33. Ns. Ferlina Jaizah Agustin, S.Kep
34. Ns. Yeni Susilowati, S.Kep

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gawat Darurat dan Kesiinambungan Pelayanan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada. Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gawat Darurat yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gawat Darurat ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 9 Januari 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Heni Indra Wulansari, S. Kep, Ns. M. Kep

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT HUSADA
NOMOR : 020.1/RSPHS/I-PER/DIR/II/2026**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo 545/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) Subsector Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
7. Kepdirjen Nomor HK-02-02-D-47104-2024 tentang Instrument Survei Akreditasi Rumah Sakit
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang standar akreditasi rumah sakit
9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43853/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit Kelas D Pratama
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
11. Kepkonsil No. 21A Th 2006 ttg Pengesahan Standar Kompetensi Dokter
12. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 935.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
13. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 (01 November 2025 hingga 31 Oktober 2026)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT
DARURAT (IGD)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dalam organisasi dan manajemen di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

BAB II SKRINING

Pasal 2

- (1) Skrining penerimaan pasien dilaksanakan melalui jalur cepat (*fast track*) kriteria triase, evaluasi visual atau pengamatan, atau hasil pemeriksaan fisik, psikologis, laboratorium klinis, atau diagnostik imaging sebelumnya.
- (2) Skrining di dalam maupun luar rumah sakit termasuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan / spesifik untuk menetapkan pasien diterima atau dirujuk;
- (3) Pelaksanaan proses skrining baik di dalam maupun di luar rumah sakit;
- (4) Skrining dilakukan untuk menilai apakah rumah sakit mampu menyediakan pelayanan yang dibutuhkan pasien serta konsisten dengan misi rumah sakit;
- (5) Pada pelaksanaan skrining, dapat ditentukan tes atau bentuk penyaringan terhadap populasi pasien tertentu sebelum menetapkan pasien dapat dilayani dengan menghubungi nomor IGD Rumah Sakit 08113789016 dan mencatat komunikasi skrining di buku baik dari faskes atau dari rumah
- (6) Pasien diterima bila rumah sakit dapat memberi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dibutuhkan pasien;
- (7) Pada proses admisi pasien rawat inap dilakukan skrining kebutuhan pasien untuk menetapkan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif yang diprioritaskan berdasar atas kondisi pasien;
- (8) Prioritas diberikan pada pelayanan terkait preventif, paliatif, kuratif dan rehabilitatif.

BAB III TRIASE

Pasal 3

- (1) Proses triase dan pelayanan kegawatdaruratan diterapkan oleh staf yang kompeten dan bukti dokumen kompetensi dan kewenangan klinisnya tersedia.
- (2) Kewajiban memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya di instalasi gawat darurat meliputi triase

-
- dan tindakan penyelamatan nyawa (*life saving*);
- (3) Triase merupakan pemeriksaan awal atau skrining secara cepat terhadap semua pasien yang datang ke instalasi gawat darurat untuk mengidentifikasi status kegawat daruratannya dan orioritas penanganan;
 - (4) Pasien darurat dinilai dan di stabilkan sesuai kapasitas rumah sakit sebelum di transfer ke ruang rawat atau dirujuk dan didokumentasikan dalam rekam medik.
 - (5) Implementasi triase di RS Prima Husada Sukorejo disesuaikan dengan Sarana dan Prasarana yang ada. Adapun pembagian triase merupakan kombinasi antara ATS dan PMK No 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

BAB IV PENUNDAAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pasien dan atau keluarga diberikan informasi jika ada penundaan dan atau keterlambatan pelayanan beserta alasannya dan dicatat di rekam medis.
- (2) Keterlambatan pada pasien adalah kondisi dimana suatu pelayanan/ tindakan melebihi durasi yang normatif;
- (3) Pasien dan atau keluarga diberi informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai dengan kebutuhan klinis pasien dan di catat dalam rekam medis.

BAB V ALUR PASIEN

Pasal 5

- (1) Alur pendaftaran pasien rawat jalan;
- (2) Alur pendaftaran pasien rawat inap;
- (3) Alur pendaftaran pasien gawat darurat;
- (4) Alur penerimaan pasien gawat daurat ke unit rawat inap;
- (5) Alur mengelola pasien bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju maupun diseluruh rumah sakit;
- (6) Proses pelaksanaan sistem pendaftaran rawat jalan dan rawat inap secara online;
- (7) Pasien gawat darurat tidak ditarik uang muka untuk pelayanan;
- (8) Alur untuk menghindari penumpukan termasuk pada keadaan bencana;
- (9) Pengelolaan yang efektif terhadap alur pasien (seperti penerimaan, asesmen dan tindakan, transfer pasien, serta pemulangan) dilaksanakan agar dapat mengurangi penundaan asuhan kepada pasien;
- (10) Komponen dari pengelolaan alur pasien meliputi :
 - (a) Ketersediaan tempat tidur rawat inap;
 - (b) Perencanaan fasilitas alokasi tempat, peralatan, utilitas, teknologi medis, dan kebutuhan lain untuk mendukung penempatan sementara pasien;
 - (c) Perencanaan tenaga untuk menghadapi penumpukan pasien di beberapa lokasi sementara dan atau pasien yang tertahan di unit darurat;
 - (d) Alur pasien di daerah pasien menerima asuhan, tindakan dan pelayanan (seperti unit rawat inap, laboratorium, kamar operasi, radiologi, dan unit pasca-anastesi);

- (e) Pemberian pelayanan ke rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien;
- (f) Akses pelayanan yang bersifat mendukung (Seperti pekerja sosial, kegamaan atau bantuan spiitual, dan sebagainya).

BAB VI HAK PASIEN DALAM PELAYANAN DAN ASUHAN

Pasal 6

- (1) Rumah sakit menetapkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga;
- (2) Pasien memiliki hak untuk menentukan informasi apa saja yang dapat disampaikan pada keluarga atau pihak lain;
- (3) Semua staff memperoleh edukasi dan memahami tentang hak serta kewajiban pasien dan keluarga;
- (4) Staff bertanggung jawab melindungi hak pasien.

Pasal 7

- (1) Setiap profesional pemberi asuhan (PPA) harus melakukan identifikasi agama dan memahami agama, keyakinan, nilai-nilai pribadi pasien, serta menghormati dan menerapkan dalam asuhan pasien yang diberikan;
- (2) Rumah sakit menanggapi permintaan rutin termasuk permintaan kompleks terkait dukungan agama dengan memfasilitasi bimbingan keohanian di rumah sakit.

Pasal 8

- (1) Rumah sakit mengatur tentang kewajiban simpan rahasia pasien dna menghormati kebutuhan privasi pasien.
- (2) Pasien diberitahu bahwa segala informasi tentang kesehatan pasien adalah rahasia dan kerahasiaan itu akan dijaga sesuai dnegan peratran perundang-undangan;
- (3) Pasien harus diminta persetujuannya untuk pelepasan informasi medis;
- (4) Staf mampu mengidentifikasi dan menghormati harapan dan kebutuhan privasi saat wawancara klinis, pemeriksaan, prosedur, pengobatan dan transfer pasien.

Pasal 9

- (1) Rumah sakit menjamin keamanan barang milik pasien dengan menyediakan tempat penyimpanan khusus dikarenakan kondisi pasien tertentu yang tidak mampu menjaga barang miliknya saat dirumah sakit;
- (2) Staf mampu menjelaskan tanggung jawabnya dalam menjaga barang milik pasien tersebut kepada pasien.

Pasal 10

Rumah sakit melakukan identifikasi populasi pasien yang rentan terhadap risiko kekerasan dan melindungi semua pasien dari kekerasan diantaranya ruang bayi, kamar opeasi dan kasir (pembayaran).

Pasal 11

- (1) Pasien dan keluarga ikut berpartisipasi dalam proses asuhan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan second opinion tanpa rasa khawatir akan mempengaruhi proses asuhannya;

-
- (2) Staf dilatih dan terlatih melaksanakan perannya dalam mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan.

Pasal 12

- (1) Pasien berhak untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, diagnosis pasti, rencana asuhan, dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta diberitahu tentang hasil asuhan termasuk kemungkinan hasil yang tidak terduga.
- (2) Pasien diberi informasi tentang kondisi medis mereka dan diagnosis pasti;
- (3) Pasien diberi informasi tentang rencana asuhan dan tindakan yang akan dilakukan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
- (4) Pasien dijelaskan bila ada tindakan yang memerlukan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) dan menjelaskan proses memberikan persetujuan;
- (5) Pasien dijelaskan hasil yang diharapkan maupun kemungkinan hasil tidak terduga dari proses asuhan dan pengobatan;
- (6) Pasien dan keluarga dijelaskan tentang haknya dalam berpartisipasi membuat keputusan terkait asuhan jika diinginkan.

Pasal 13

- (1) Rumah sakit mengatur pelaksanaan proses untuk menjawab pertanyaan informasi kompetensi dan kewenangan dari PPA.
- (2) Pasien dijelaskan diagnosis, kondisi pasien, tindakan yang diusulkan, tata cara dan tujuan tindakan, manfaat dan resiko tindakan, DPJP pelaksana tindakan, kemungkinan alternatif dari tindakan, prognosis, kemungkinan hasil yang tidak terduga serta kemungkinan hasil bila tidak dilakukan tindakan;
- (3) DPJP, PPJA, dan PPA harus memperkenalkan diri saat pertama kali bertemu pasien.

Pasal 14

- (1) Pasien serta keluarganya berhak untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan.
- (2) Pasien dan keluarga dijelaskan konsekuensi dari keputusan yang diambil, dan harus bertanggung jawab terkait dengan keputusan tersebut;
- (3) Pasien dan keluarga dijelaskan tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.

Pasal 15

Rumah sakit menetapkan peraturan pada saat pasien menolak pelayanan resusitasi, menunda atau melepas bantuan hidup dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma, agama, dan budaya masyarakat.

BAB VII TRANSFER INTRAHOSPITAL

Pasal 16

- (1) Transfer pasien antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dilengkapi dengan form transfer pasien.
- (2) Form tersebut memuat indikasi pasien masuk dirawat;

- (3) Form tersebut memuat riwayat kesehatan, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan diagnostic;
- (4) Form tersebut memuat setiap diagnosis yang dibuat;
- (5) Form tersebut memuat setiap prosedur yang dilakukan;
- (6) Form tersebut memuat obat yang diberikan dan tindakan lain yang dilakukan;
- (7) Form tersebut memuat keadaan pasien pada waktu dipindah (transfer).
- (8) Ketentuan tersebut dilaksanakan.

BAB VIII RUJUKAN

Pasal 17

- (1) Rujukan dilaksanakan atas persetujuan pasien atau keluarga.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah pasien dan / atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya meliputi :
 - (a) Diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - (b) Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - (c) Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - (d) Transportasi rujukan;
 - (e) Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

Pasal 18

Hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan rujukan adalah :

- (1) Melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- (2) Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat;
- (3) Membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.

Pasal 19

Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c sekurang-kurangnya memuat :

- (1) Identitas pasien;
- (2) Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
- (3) Diagnosis kerja;
- (4) Terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
- (5) Tujuan rujukan;
- (6) Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang membeikan pelayanan.

Pasal 20

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien.
- (2) Selama proses transportasi rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis;

-
- (3) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan.

Pasal 21

Pasien atau keluarga diberi penjelasan apabila rujukan yang dibutuhkan tidak dapat dilaksanakan dengan memaut

- (1) Penundaan pelayanan;
(2) Lembar edukasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 sampai pasal 21 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 23

Peraturan direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 9 Januari 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

Heni Indra Wulansari, S. Kep, Ns. M. Kep

**LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 020.1/RSPHS/I-PER/DIR/I/2026
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI
GAWAT DARURAT (IGD)**

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI GAWAT DARURAT

**BAB I
PENDAHULUAN**

Rumah sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan memberikan dua jenis pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan, dan unit rawat inap. Dalam perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik RS yang pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, rumah sakit pun semakin meningkatkan pelayanannya. Pelayanan rumah sakit saat ini tidak hanya bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat rehabilitatif (pemulihan) yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

Pedoman organisasi rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit harus melaksanakan beberapa fungsi, satu diantaranya adalah fungsi menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan nonmedik. Dalam hal penunjang medik, salah satu pelayanan yang penting adalah pelayanan farmasi. Instalasi farmasi di rumah sakit merupakan satu-satunya unit di rumah sakit yang mengadakan barang farmasi yang beredar di rumah sakit serta bertanggung jawab atas pengadaan dan penyajian informasi obat yang siap pakai bagi semua pihak di rumah sakit, baik petugas maupun pasien. Instalasi farmasi di rumah sakit harus memiliki organisasi yang dipimpin oleh apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

BAB II
GAMBARAN UMUM RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

- 2.1 Deskripsi RS Prima Husasa
Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo berada di JL Raya Surabaya - Malang No.Km.54, Palang, Lemahbang, Kec. Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur 6716. Rumah Sakit Prima Husada adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 2 Kepala Bidang dan 3 Kepala Bagian. Yaitu Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, Kepala Bidang Operasional, Kepala Bagian SDM, Kepala Bagian Keuangan dan Akutansi, dan Kepala Bagian Umum. Rumah Sakit Prima Husada dengan pelayanan meliputi pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Kamar Operasi, Penunjang Medik, dan Penunjang Non Medik, ICU, HD, serta Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari kelas I, II, III, VIP. Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik – baiknya sebagai *public service*. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik – kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
- 2.2 Sejarah Institusi RS Prima Husada
Berawal dari Praktek pribadi dr. Sadi Hariono, MMRS sebagai dokter umum sejak tahun 1990 di Banjararum Selatan No. 3B, kami telah mengabdikan diri melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kamipun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada.

Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan :

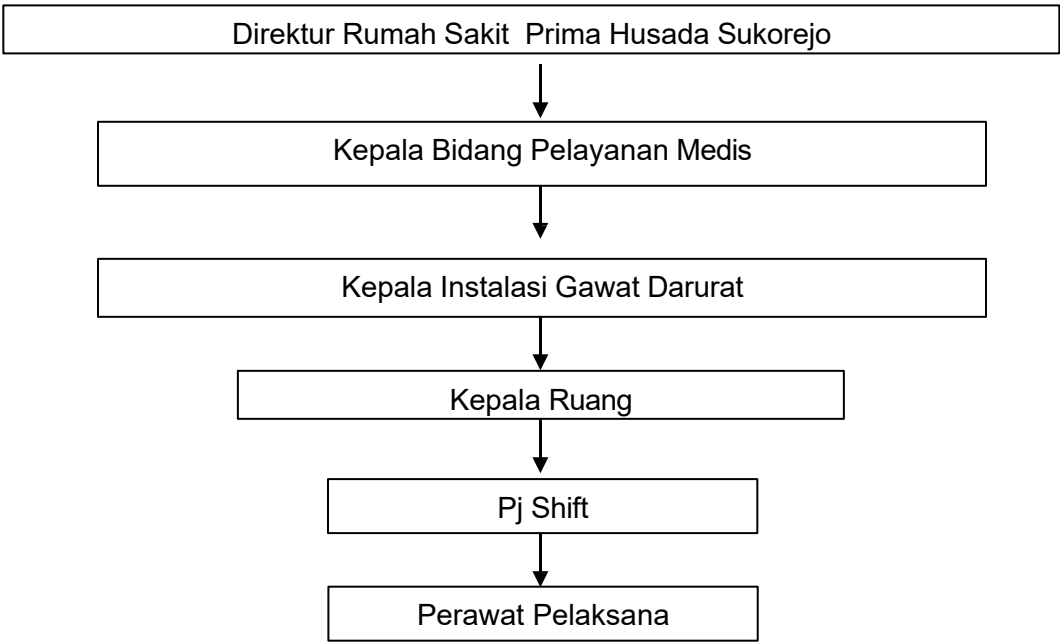
Tahun 1990 – 2005	: Praktek Pribadi Dokter Umum
Tahun 2005 – 2009	: Balai Pengobatan Prima Husada
Agustus 2009	: Klinik Rawat Inap Layanan Medik Dasar
Mei 2010	: Menjadi Rumah Sakit Umum dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2010 – 2014	: Izin Operasional Rumah Sakit Sementara
Februari 2015	: Izin Operasional Rumah Sakit Tetap
Februari 2016	: Penetapan Rumah Sakit Tipe C
Maret 2016	: Akreditasi Paripurna
Desember 2016	: Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Malang Raya Tahun 2016
April 2017	: Juara 1 Pelayanan dan Respon terbaik (Dinkes Kab. Malang)
Desember 2017	: Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Jawa Timur Tahun 2017
Desember 2017	: Pengembangan Gedung DPM
Februari 2018	: Menjadi tempat dokter internsip

BAB III

VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN

- 3.1 Visi
Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.
- 3.2 Misi
 - 1. Memberikan pelayanan yang aman, tepat, cepat dan akurat.
 - 2. Mengutamakan kepuasan pasien.
 - 3. Melanjutkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.
- 3.3 Landasan 7 Nilai Budi Utama
 - 1. Jujur
 - 2. Tanggung jawab
 - 3. Disiplin
 - 4. Visioner
 - 5. Kerjasama
 - 6. Adil
 - 7. Peduli
- 3.4 Tujuan
Rumah Sakit Prima Husada menjadi Rumah Sakit yang memberikan solusi kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Malang dan sekitarnya.
- 3.5 Motto
Sahabat menuju sehat
- 3.6 Falsafah
Memberikan pelayanan secara profesional berlandaskan hati nurani yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI GAWAT DARURAT



BAB V
TATA LAKSANA PELAYANAN

5.1 Uraian Jabatan

No	Nama jabatan	Persyaratan jabatan
1	Kepala Instalasi Gawat Darurat	1. Pendidikan : - Lulusan S1 Pendidikan Dokter/ Dokter Spesialis - Memiliki STR dan SIP Dokter yang masih berlaku, Surat sumpah dokter 2. Pengetahuan dan Keterampilan : - Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi - Mempunyai kemampuan menangani pasien umum, gawat darurat & Penggunaan alat medis yg berhubungan dgn penanganan pasien IGD 3. Pengalaman : Pengalaman di bidang klinis minimal 3 tahun 4. Uraian tugas - Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh pelayanan IGD - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. - Mengenal dan mengetahui penggunaan barang/alat serta mengusahakan pengadaannya. - Menyusun permintaan rutin kebutuhan ruangan. - Mempertanggung jawabkan pemeliharaan alat/inventaris peralatan. - Memelihara dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan semua kegiatan di ruangan. - Memberikan penjelasan pada pasien IGD dan keluarganya sebatas kewenangannya. - Bekerja sama dengan seluruh sub unit dan profesi di RS Prima Husada - Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. - Memotivasi tenaga medis, perawatan dan non perawatan dalam menjaga kebersihan - Menilai pelaksanaan SPO medis dan asuhan keperawatan - Menilai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dibidang medis dan keperawatan - Mengendalikan pendayagunaan peralatan, keperawatan, obat-obatan secara efektif dan efisien. - Mengatur jadwal jaga dokter dan perawat IGD - Sebagai Dokter Full Timer - Mengikuti rapat dan kegiatan yang diselenggarakan rumah sakit.
		5. Tanggung Jawab - Bertanggung jawab Kepada Direktur Rumah Sakit Prima

		Husada. - Membantu dalam menyusun rencana kerja sesuai tujuan dan target pelayanan yang ditetapkan oleh rumah sakit. - Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab, serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas.
		6. Wewenang - Melaksanakan pelayanan medik di IGD - Menyelenggarakan kegiatan ruangan bermutu - Melakukan konsul pasien ke konsulen yang bersangkutan atau merujuk pasien sesuai kebutuhan - Mengusulkan memindahkan pasien dari ruang perawatan biasa ke ruang ICU
2	Kepala Ruang	1. Pendidikan : - Lulusan S1 Keperawatan - Memiliki STR dan SIKP Perawat yang masih berlaku, Surat sumpah jabatan - PPGD/BTLS/BCLS/BLS 2. Pengetahuan dan Keterampilan : Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 3. Pengalaman : Pengalaman di bidang klinis minimal 1 tahun 4. Uraian tugas : - Mengatur dan mengkoordinasi seluruh pelayan IGD seperti pelaksanaan kegiatan, kebutuhan sumber daya manusia, anggaran pendapatan dan belanja tahunan, pengorganisaian pelaksanaan tugas, petunjuk teknis pelayanan IGD, petunjuk teknis tugas IGD, menerima, mendata dan melaporkan kepada atasan tentang adanya masalah ataupun kasus – kasus di IGD sekaligus melakukan perbaikan. - Memperbaiki pengarah dan motivasi kepada tenaga medis, keperawatan dan tenaga lainnya. - Bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan di ruangan IGD - Mengadakan pertemuan berkala, membahas permasalahan atau perkembangan baru di unit IGD - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan - Mengenal dan mengetahui penggunaan barang / alat serta mengusahakan pengadaannya. - Menyusun permintaan rutin kebutuhan ruangan. - Mempertanggung jawabkan pemeliharaan alat/inventaris peralatan. - Memelihara dan mengembangkan system peralatan dan pelaporan semua kegiatan di ruangan. - Memberikan penjelasan pada pasien IGD dan keluarganya sebatas kewenangannya. - Bekerja sama dengan seluruh sub unit dan profesi di RS Prima husada. - Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik - Memotivasi tenaga medis, perawatan dan non perawatan dalam menjaga kebersihan - Menilai pelaksanaan SPO medis dan asuhan

		keperawatan - Menyusun rencana kegiatan berdasarkan jenis, jumlah, mutu tenaga keperawatan serta tenaga lainnya sesuai kebutuhan di IGD. - Berkoordinasi dengan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dalam menyusun rancang ulang program peningkatan mutu di Instalasi Gawat Darurat dan melaksanakannya. - Menyusun dan mengatur daftar dinas tenaga perawat yang berlaku tiap minggu. - Melakukan tindakan darurat sesuai dengan kebutuhan pasien seperti mengamati keadaan pasien (tanda vital, kesadaran, mental, keluhan), melakukan anamnesa, menyiapkan bahan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan. - Membantu pasien selama pemeriksaan dokter dengan cara : memberikan penjelasan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan, menyiapkan pasien untuk tindakan pemeriksaan. - Memastikan bahwa semua hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium telah tervalidasi dengan baik dan benar - Memastikan bahwa semua hasil nilai kritis laboratorium telah dilaporkan dengan baik dan benar. - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang laboratorium, antara lain melalui pertemuan ilmiah dan pelatihan. - Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah dibuat. - Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi dan rancang ulang program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di unitnya. - Melakukan evaluasi terhadap perijinan bagi diri sendiri, staf di bawahnya, fasilitas yang ada dan hal-hal terkait, sesuai peraturan perundangan dan hukum yang berlaku. - Melakukan evaluasi terhadap mutu dari proses kerja sama dengan unit dan instansi lain. - Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan secara rutin. - Menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana - Good attitude (tidak hanya sikap baik tetapi juga sifat yang baik dan pikiran positif). - Mengerti tentang obat-obatan yang tersedia di rumah sakit dan ketentuan atau program-program rumah sakit. - Melakukan triase saat pasien pertama kali masuk Instalasi Gawat Darurat. - Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang sederhana menegakan diagnosis kerja setiap pasien baru masuk dan kemudian memberikan tindakan dan terapi emergensi sesuai dengan diagnosis sementara yang ditegakkan sesuai dengan disiplin ilmu dan kewenangan klinis kemudian di dokumentasikan pada asesmen IGD.
--	--	--

		- Melakukan monitoring pasien gawat darurat sampai keadaan pasien stabil untuk dilakukan transfer. - Datang tepat waktu sesuai dengan shift jaga. - Mengkonsulkan pasien yang akan di rawat inapkan kepada DPJP sebelum masuk ruangan. - Membantu pertolongan bagi pasien rawat inap yang membutuhkan pertolongan gawat darurat dalam kondisi dokter ruangan tersebut halangan atau menangani pasien emergency lain. - Berperan aktif dalam penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. - Melaksanakan tugas luar rumah sakit jika diperlukan sewaktu-waktu. - Mengikuti rapat yang diselenggarakan rumah sakit. - Melaksanakan pelayanan medis di IGD selama 24 jam secara bergiliran.
		5. Tanggung Jawab : - Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi gawat darurat. - Bertanggung jawab atas pelayanan dan ketenagaan keseharian di Instalasi gawat darurat.
		6. Wewenang - Membantu Kepala Instalasi untuk melakukan tugas rutin di instalasi gawat darurat. - Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan. - Pengembangan tata laksana kerja, tugas-tugas, dan tanggungjawab. - Melakukan pembagian tugas di lingkup internal instalasi gawat darurat. - Membantu melaksanakan program orientasi untuk karyawan di IGD - Melakukan evaluasi kinerja, sumber daya manusia dalam lingkup kinerjanya. - Menyiapkan sarana,prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan. - Melakukan sosialisasi mengenai peraturan/tata tertib yang berlaku di rumah sakit serta fasilitas yang ada dan cara penggunaanya. - Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya. - Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan instalasi/bagian lain yang terkait. - Berperan serta dalam membahas kasus sebagai upaya untuk meningkatkan mutu. - Mengusulkan rencana kebutuhan tenaga perawat dari segi jumlah maupun kualifikasi di instalasi gawat darurat. - Memantau penerapan SOP dan mengevaluasi.
3	Perawat Pelaksana	• Pendidikan - Lulusan S1/ D3 Keperawatan - Memiliki STR dan SIKP Perawat yang masih berlaku,

		Surat sumpah jabatan - PPGD/BTLS/BCLS/BLS • Pengetahuan dan Keterampilan : - Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 3. Pengalaman : - Pengalaman di bidang klinis minimal 1 tahun • Uraian tugas : - Menyiapkan fasilitas dan lingkungan UGD untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan - Melayani pasien baru sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku - Melakukan tindakan medis /intervensi kepada pasien sesuai dengan kapasitasnya - Membantu dokter dalam memberika pelayanan / pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat dan darurat - Memelihara peralatan kesehatan / medis agar selalu dalam keadaan siap pakai - Menciptakan hubungan kerjasama yag baik dengan pasien dan keluarganya maupun sesama petugas - Mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan pasien sesuai dengan batas kemampuanya,dengan cara: a. Mengamati keadaan pasien (tanda vitak, kesadaran, keadaan mental , keluha utama) b. Melaksanakan anamesa c. Menyiapkan formulir untuk penyelesaian adminitrasi, seperti: - Surat keteranga istirahat sakit, jika diperlukan - Resep obat untuk dirumah, jika diperlukan - Surat rujukan atau pemeriksaan ulang d. Perincian biaya pengobatan pasien - Memberikan Penyuluhkan kesehatan kepada pasien dan keluarganya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pasien, menenai : - Diit - Pengobatan yang perlu dilanjutkan dan cara penggunaanya - Pentingnya pemeriksaan ulang / kontrol dirumah sakit, puekesmas atau instalasi pelayanan kesehatan lainnya - Cara hidup sehat, seperti pegaturan istirahat, makanan yang berizi • Mengatur pasien yang akan dirawat sampai ke ruangan yang dituju • Mengatur pasien yang akan pulang sampai dipintu keluar ruang UGD bila keadaan memungkinkan. • Melakukan pengecekan alat setiap pergantian shift serta membersihkan,merapikan,dan menyiapkan alat setelah dipakai untuk tindakan berikutnya. • Melakukan pengecekan obat serta melengkapi stock obat setelah obat dipakai degan cara mengambil pergantian obat dari pasien • Menyiapkan BHP untuk keperluan IGD • Bekerjasama untuk menjaga , memelihara ,membersihkan ,merapikan alat –alat yang ada di IGD.
--	--	--

		• Membuat laporan harian pasien • Membuat asuhan keperawatan (melengkapi status IGD) • Disiplin - Datang tepat waktu - Mengisi absensi - Berpakaian rapi dan bersih - Ramah,sopan,santun (beretika) - Mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku dirumah sakit raflesia. • Melakukan perhitungan dan pencatatan perincian biaya pasien IGD yang dilakukan oleh shift malam dan shift pagi melaporkanya keuangan setiap harinya • Bekerja secara professional 5. Tanggung Jawab Langsung : Kepala Ruang UGD Tidak langsung : Kabid Keperawatan 6. Wewenang • Meminta informasi dan petunjuk pada atasan • Memberi asuhan Keperawatan pada pasien/ keluarga pasien sesuai dengan kemampuan dan batas kewenangannya.
--	--	--

5.2 Tugas Klinis

Tugas klinis yang dimaksud adalah seseorang yang bekerja di bidang manajemen mempunyai uraian tugas jabatan dan uraian tugas fungsional dan dilengkapi oleh SPK dan RKK

A. Dokter

NO	KOMPETENSI
	• Kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. • Kewajiban merujuk pasien ke dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. • Kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. • Kewajiban melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. • Kewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. • Kewajiban untuk menunjuk staf medis lain dalam keahlian yang sama sebagai pengganti apabila berhalangan, jika tidak harus diinformasikan kepada pasien yang

	bersangkutan. • Kewajiban untuk memberikan penjelasan secara lengkap kepada pasien sebelum persetujuan tindakan disetujui pasien (informed consent). • Kewajiban membuat rekam medis dan mematuhi petunjuk pelaksanaannya. • Kewajiban menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya. • Kewajiban untuk mematuhi kebijakan rumah sakit tentang obat dan formularium rumah sakit.
--	--

- B. Perawat
- Perawat Klinik I
Perawat klinis I adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan dasar dengan penekanan pada keterampilan teknis keperawatan dibawah bimbingan.
 - Perawat Klinik II
Perawat klinis II adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan holistik pada klien secara mandiri dan mengelola klien/sekelompok klien secara tim serta memperoleh bimbingan untuk penanganan masalah lanjut/kompleks.
 - Perawat Klinik III
Perawat Klinis III adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan komprehensif pada area spesifik dan mengembangkan pelayanan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah dan melaksanakan pembelajaran klinis.
 - Perawat Klinik IV
Perawat klinis IV adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhankeperawatan pada masalah klien yang kompleksdiarea spesialistik dengan pendekatan tata kelolaklinis secara interdisiplin, multidisiplin, melakukanriset untuk mengembangkanpraktek keperawatanserta mengembangkan pembelajaran klinis.
 - Perawat Klinik V
Perawat klinis V adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan memberikan konsultasi klinis keperawatan pada area spesialistik, melakukan tatakelola klinis secara transdisiplin, melakukan riset klinis untuk pengembangan praktik, profesi dan kependidikan keperawatan.

TATA HUBUNGAN KERJA

6.1 Pola Hubungan dengan Instalasi/Unit Pelayanan Struktural

No.	Unit/Instalasi Terkait	Uraian Hubungan Kerja
1.	<i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	1. Transfer pasien antar bagian
2.	Instalasi Kamar Operasi (IKO)	1. Transfer pasien antar bagian
3.	Instalasi Rawat Inap (IRNA)	1. Transfer pasien antar bagian
4.	Instalasi Rawat Jalan (IRJA)	1. Transfer pasien antar bagian

6.2 Pola Hubungan dengan Instansi/Penunjang

No.	Unit/Instalasi Terkait	Uraian Hubungan Kerja
1.	Instalasi Prasarana dan Sarana RS (IPSRS)	1. Perbaikan peralatan dan sarana instalasi Unit Gawat Darurat 2. Pengkondisian lingkungan area instalasi Unit Gawat Darurat.
2.	Unit Pengadaan	Pengadaan sediaan alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
3.	Instalasi Rekam Medik	1. Laporan bulanan dan tahunan di instalasi Gawat Darurat
4.	Bagian Administrasi	Keperluan data dan dokumen.
5.	Unit Keuangan	1. Laporan Stock Opname. 2. Laporan penjualan umum. 3. Laporan penjualan pasien jaminan.
6.	Unit Humas	1. Survei kepuasan Pasien. 2. Standar Pelayanan Minimal.
7.	Tim IT	1. Pengecekan komputer dan perangkatnya. 2. Perbaikan program <i>Billing</i> SIMRS.
8.	Umum	1. Kebersihan ruangan. 2. Persiapan ruangan untuk <i>event</i> .
9.	Kasir	Pembayaran pelayanan rawat inap dan rawat jalan.

POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI

7.1 Pola Ketenagaan

Penyusunan Pola Ketenagaan Sebagai Dasar Penempatan Staf dalam upaya mempersiapkan tenaga perawat yang handal perlu adanya perencanaan SDM. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

Standar tenaga keperawatan di RS sesuai Depkes RI 2005 perhitungan pola ketenagaannya sebagai berikut :

No	Kategori Pasien	Rata2 jumlah pasien/ hr	Jumlah jam perawatan px/ hr	Jumlah jam perawatan/ hr (C x D)
A	B	C	D	E
1	Minimal Care	18	2	36
2	Partial Care	11	3,08	33,88
3	Total Care	1	4,15	4,15
4	Intensive Care	0	0	0
	Jumlah	30		74,03

- a. Jumlah jam perawatan di ruangan / hari = 74,03 jam
- b. Jam efektif perawat = 7
- c. Jumlah hari minggu (1 tahun) = 52
- d. Perkiraan cuti = 12 hari
- e. Hari besar (1 tahun) = 14 hari
- f. Jumlah hari kerja efektif = 286 hari
- g. Koreksi 25 %

Sehingga jumlah perawat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

Langkah 1 : $\frac{74,03}{7} = 10,5$

Langkah 2 : $\frac{52 + 12 + 14}{286} = \frac{78 \text{ hari} \times 10,5}{286} = 2,8$

Langkah 3 : $\frac{10,5 + 2,8}{100} \times 25 = 3,3$

Langkah 4 : Jadi jumlah tenaga perawat yang di butuhkan di Instalasi Gawat Darurat adalah :
 $10,5 + 2,8 + 3,3 = 16,6 \square 17 \text{ orang} + 1 \text{ karu} = 18 \text{ orang}$

Tabel Pola Kebutuhan Instalsi Gawat Darurat

NAMA JABATAN	PENDIDIKAN	SERTIFIKASI	JUMLAH KEBUTUHAN
Ka Instalasi	Dokter	ACLS/BCLS Code Blue HIPERKES PMKP	1
Ka Ruangan	S1 Keperawatan	PPGD PMKP Code Blue Komunikasi Efektif K3RS PPI	1
Perawat pelaksana	D3 Keperawatan	PPGD PMKP Code Blue Komunikasi Efektif K3RS PPI	17

Untuk jumlah dokter umum pada RS tipe C sesuai PMK 56 tahun 2014 adalah sebanyak 9 orang.

7.2 Penempatan dan Penempatan Kembali Staf

Perencanaan kebutuhan yang tepat dengan jumlah yang mencukupi adalah hal yang sangat penting bagi asuhan pasien termasuk keterlibatan rumah sakit dalam semua kegiatan pendidikan dan riset. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi. Sebagai contoh, seorang perawat yang memiliki kompetensi hemodialisis tidak dirotasi ke rawat jalan lain.Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan proses yang sudah diakui untuk menentukan jenjang kepegawaian. Perencanaan kepegawaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf;
 - Staf yang mempunyai kompetensi tambahan seperti pelatihan Instrumen, pelatihan Kegawatdaruratan Perinatologi, Pelatihan ICU dasar, Pelatihan Anestesi tidak dapat dirotasi ke unit lain dikarenakan terdapat unit prioritas yang khusus membutuhkan kompetensi tambahan tersebut. Misalnya Staf yang memiliki pelatihan Instrumen, ditempatkan di Instalasi Kamar operasi, sebaliknya staf yang mempunyai kompetensi ICU dasar di tempatkan di *Instalasi Care Unit*
 - Penempatan staf dapat dilakukan apabila dalam unit tersebut terdapat kebutuhan mendesak sedangkan staf yang dibutuhkan belum tersedia, maka staf tersebut di rotasi sementara untuk menjaga stabilitas pelayanan dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan Rincian Kewenangan Klinis yang sesuai.
- b. Mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama;Mengkaji keinginan staf untuk ditempatkan pada unit yang sesuai berdasarkan hasil psikotest, menggali nilai kepribadian staf apakah lebih berpotensi pada unit pelayanan atau manajemen, atau bahkan marketing yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
- c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang -undangan

Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi, surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis yang telah disetujui Direktur RS Prima Husada dengan tetap mengacu pada peraturan perundan-undangan yang berlaku.

7.3 Evaluasi dan Pemutakhiran Staf

- a. Pemutakhiran dan evaluasi staf dilakukan setiap satu tahun sekali dan dilaporkan tiap bulan di laporan bulanan
- b. Dihadiri oleh Direktur, Kepala Bidang, Kepala Unit, SDM
- c. Setiap ada staf yang melakukan pengunduran diri
- d. Setiap penambahan jenis pelayanan, jumlah pasien dan jumlah alat yang mempengaruhi perhitungan awal pola ketenagaan

7.4 Jumlah Staf Unit

7.5 Seleksi Calon Karyawan

Seleksi calon karyawan adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk mengundang para pelamar sebanyak mungkin sehingga Instalasi Gawat Darurat memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan calon yang paling sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan. Seleksi calon karyawan dilakukan karena berdasarkan analisa kebutuhan tenaga, ditemukan jumlah pasien dan kegiatan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada.

Berdasarkan sumber seleksi calon karyawan dapat dibagi dua yaitu:

- a. Dari dalam Rumah Sakit Prima Husada sendiri (*internal resources*)
Menarik calon dari dalam RS Prima Husadasendiri (*Internal resources*) memiliki keuntungan lebih yaitu calon sudah dikenal dengan kinerja yang baik dan proses dapat dilakukan dengan lebih cepat dibanding menarik calon dari luar RS Prima Husada. Untuk mendapatkan calon pelamar dapat melalui berkas-berkas pelamar yang masuk ke rumah sakit Prima Husada.
- b. Dari luar RS. Prima Husada (*external resources*)
Proses penarikan calon dari luar RS. Prima Husada ini dapat dilakukan dengan cara iklan media cetak dan kerja sama dengan lembaga pendidikan tentang kebutuhan dengan kualifikasi tertentu.

7.6 Pengembangan SDM

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di Intalasi Gawat Darurat khususnya dan Rumah Sakit Prima Husada umumnya, diperlukan pembinaan/pengembangan kompetensi tenaga perawat. Pembinaan/ pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksanaan tugas dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan menambah pengetahuan wawasan bidang pelayanan keperawatan.

Pengembangan sumber daya manusia dapat di lakukan dengan dua cara yakni:

- 1. Pendidikan
Tenaga dengan pendidikan setingkat Diploma III diberi ijin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners.
- 2. Pelatihan
Pelatihan untuk peningkatan kompetensi perawat di Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan melalui :
 - a. *Internal Training* yaitu program pelatihan yang diselenggarakan oleh RS Prima Husada, yang sudah dilaksanakan yaitu pelatihan PPI dasar dan standar keselamatan pasien, komunikasi efektif, pelatihan apar dan BHD.
 - b. *External Training* yaitu program pelatihan diluar rumah sakit yang diikuti sesuai dengan kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit khususnya mutu pelayanan IGD.

KEGIATAN ORIENTASI

Kegiatan orientasi yang diselenggarakan di instalasi gawat darurat rs prima husada, antara lain adalah sebagai berikut :

HARI KE	MATERI	WAKTU	METODE	PENANGGUNG JAWAB
1	Penjelasan status kepegawaian Penjelasan program orientasi yang akan diterima pegawai, peraturan dan tata tertib masa orientasi Kepada pegawai dikenalkan seluruh unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Orientasi di unit kerja dimana pegawai ditempatkan Pegawai diberikan berbagai materi orientasi dengan penjadwalan khusus meliputi : 1. Visi, misi, nilai, struktur organisasi 2. Perjanjian kerja 3. Etika bekerja 4. Kesejahteraan spiritual 5. Service excellence 6. Handling complaints 7. Produk produk rumah sakit 8. <i>Basic life support</i> 9. Penanggulangan bencana kebakaran 10. Patient safety 11. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	7 jam	Ceramah dan Diskusi	SDM
2	Mempelajari SPO Keperawatan. Mempelajari Pedoman Pelayanan dan Pedoman Organisasi Instalasi IGD	2 jam	Ceramah, membaca , dan diskusi	Kepala Ruang IGD
3	Pengenalan teknik triase, anamnesa dan pemeriksaan.	2 jam	Ceramah, membaca , dan diskusi	Kepala ruang IGD
4.	Mempelajari dan praktek alur transfer pasien IGD ke IRNA.	5 jam	Ceramah, diskusi, dan	Kepala ruang IGD

	Mempelajari tata cara penentuan dan penerimaan kriteria masuk dan keluar IGD		praktek	
5.	Mempelajari dan praktek alur pelayanan pasien yang membutuhkan instalasi Rawat Inap maupun Rawat JAlan. Pengisian RM pasien. Konsul dan Visite dokter. Mempelajari <i>items</i> pada SIM-RS instalasi Gawat Darurat.	7 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	Kepala ruang IGD

PERTEMUAN RAPAT

Rapat merupakan suatu pertemuan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk membicarakan atau memecahkan suatu masalah tertentu. Tujuannya sebagai berikut :

1. Dapat membantu terselenggaranya pelayanan keperawatan yang profesional di Instalasi IGD Rumah Sakit Prima Husada.
2. Dapat menggali segala permasalahan terkait dengan pemberian pelayanan di Instalasi IGD.
3. Dapat mencari jalan keluar atau pemecahan permasalahan yang terkait dengan pelayanan di Instalasi IGD.

Rapat terdiri dari 2 macam yaitu :

Rapat Rutin

1. Rapat koordinasi antar unit diselenggarakan pada setiap sabtu jam 13.30 s/d selesai di Hall Akasia. Rapat ini dihadiri oleh kepala instalasi, kepala ruangan, dan unit-unit terkait untuk membahas tentang koordinasi antar unit dalam satu RS.
2. *Daily report* dilakukan setiap hari jam 13.00-14.00 yang bertempat di Hall . Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing unit untuk membahas permasalahan di masing-masing unit serta update informasi terbaru mengenai RS Prima Husada.
3. Rapat internal Instalasi IGD dilakukan pada minggu pertama 1 bulan sekali. Rapat ini dihadiri oleh seluruh tim Instalasi IGD RSPH untuk membahas permasalahan internal ataupun eksternal, koordinasi internal, *update* keilmuan, dan lain-lain.

Rapat Insidentil

Rapat Insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada masalah atau sesuatu hal yang perlu dibahas dan sosialisasi kebijakan baru.

BAB X PENUTUP

Demikian buku Pedomana Pengorganisasian Instalasi Gawat Darurat ini disusun. Kami mengajak semua pihak yang bekerja di RS Prima Husada untuk dapat bersama-sama membina dan mengembangkan sistem pelayanan di IGD. Semua petugas baik tenaga medis, paramedis, maupun non medis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan gawat darurat hendaknya selalu mentaati ketentuan yang telah digariskan didalam buku pedoman ini.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 9 Januari 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Heni Indra Wulansari, S. Kep, Ns. M. Kep

